

DFGSO2 / Dentaire 2A	Dentisterie Restauratrice	n°3
----------------------	---------------------------	-----



DFGSO2 – BORDEAUX

RONÉOS 2025/2026



Enseignant : Dr. O. KEROUREDAN	Date et horaire : 05/11/24 de 16h à 17h
Ronéistes :	Référents :
• Lucie Texier • Louane Florek	• Bouridane Nour • BOUKHATMI faiza

UE Dentisterie Restauratrice

ED n°3 : Séance de Questions-Réponses (Vrai / Faux)

Question n°1 : Les lésions cervicales non carieuses (LCNC) sont causées par des bactéries.

FAUX.

Les LCNC sont majoritairement causées par tout ce qui est mécanique (**abfraction** et **abrasion**) et érosif (**érosion**) qui peut entraîner des pertes de substance.

Rappel : L'**abfraction** est causée par des contraintes occlusales excessives, entraînant une fragmentation à la jonction amélo-cémentaire. Cela crée une lésion angulaire, caractérisée par la fragmentation des tissus et une perte de substance.

Tout ce qui est causé par une bactérie, ça fait référence aux lésions carieuses.

Question n°2 : L'abfraction est une forme de LCNC due aux contraintes occlusales.

VRAI.

Oui, comme on l'a dit plus haut, l'abfraction est liée aux contraintes occlusales : elle entraîne une fragmentation.

Question n°3 : Le vieillissement du parodonte peut entraîner des récessions gingivales.

VRAI.

Les récessions gingivales, au-delà du déchaussement des dents et de problèmes parodontaux supplémentaires (inflammations), peuvent notamment favoriser **davantage de lésions carieuses au niveau radiculaire** dû à l'exposition radiculaire.

On peut avoir des récessions gingivales quand on est jeune, mais les patients plus âgés, notamment ceux qui sont dépendants en Ehpad, sont plus susceptibles d'en avoir. En Ehpad ou à l'hôpital, il y a plein de patients qui auront davantage de lésions carieuses au niveau radiculaire car le ciment est moins minéralisé que l'émail en termes de structure : il est plus poreux et donc beaucoup plus susceptible aux agressions (mécanique ou chimique). Le ciment est plus cariosusceptible : on va avoir davantage de lésions carieuses. On va également avoir davantage de lésions d'usure (LCNC) sur ces zones-là et aussi parfois davantage de sensibilité.

Quand on a une récession gingivale, ça va exposer un peu la racine et ça va créer des **hyperesthésies dentinaires**, donc des hypersensibilités au chaud, au froid etc. Indirectement, ça peut avoir des répercussions au niveau pulpaire car quand on a une perte de substance au niveau radiculaire, très rapidement on va se situer au niveau de la pulpe et on va avoir des complications **inflammatoires** ou **infectieuses**.

Question n°4 : La perte de structure dentaire par érosion est réversible.

FAUX.

C'est irréversible.

Il faut d'ailleurs faire de la prévention auprès du patient en lui expliquant que toutes les pertes de substances qu'on a là sont des pertes irréversibles et qu'elles vont se cumuler dans le temps. S'il n'y a rien de mis en œuvre en termes de thérapeutiques préventives, ça va s'accroître dans le temps jusqu'à une dégradation assez conséquente de la dent.

Seules les érosions très superficielles, au stade précoce de déminéralisation, peuvent potentiellement être reminéralisées. Cette reminéralisation est possible grâce à l'action naturelle de la salive ou à des traitements spécifiques, mais uniquement pour des érosions extrêmement superficielles. Dès que la perte de substance atteint un niveau micrométrique, elle devient irréversible.

Question n°5 : L'attrition est causée par le contact direct entre les dents.

VRAI.

L'**attrition** est caractérisée par une surface plane, lisse, avec des angles vifs. Elle survient entre dents antagonistes, car elle résulte directement des frottements occlusaux répétés entre les dents. Il y a une correspondance avec la surface de la dent antagoniste. C'est cette usure mécanique, due au contact prolongé entre les dents, qui la distingue.

On le retrouve souvent chez les patients qui font notamment du bruxisme. Cette condition, associée à une dysfonction occlusale, entraîne une charge occlusale excessive et une usure plus importante au niveau des dents.

On retrouve cette usure prononcée au niveau des dents antérieures sur les patients qui n'ont pas de calage postérieur, c'est-à-dire des patients qui se sont fait extraire par exemple leurs molaires, qui n'ont plus que les prémolaires et les incisives. Cela entraîne des contraintes masticatoires excessives sur les dents antérieures, qui se retrouvent à supporter une charge qu'elles n'ont normalement pas à gérer (dérèglement de la répartition des contraintes masticatoires qui entraîne l'usure prononcée des dents antérieures).

En conséquence, cela génère des pertes de substance de type **attritionnel**, surtout si les édentements postérieurs n'ont pas été compensés.

L'une des premières choses qu'il faut faire face à un patient, c'est vérifier la répartition des charges occlusales et vérifier qu'il n'y a pas d'édentements à compenser avec une réhabilitation prothétique.

Question n°6 : L'érosion dentaire est due uniquement à des acides d'origine alimentaire.

FAUX.

On a différentes origines d'érosion dentaires :

- Extrinsèques
 - **Alimentation** : manière de la prise alimentaire : fréquence de la consommation, combien de temps dure la prise alimentaire, quels intervalles de temps entre les prises alimentaires, quel type d'alimentation
 - **Prise médicamenteuse** (antidépresseurs qui diminuent le flux salivaires, médicaments effervescents plus nocifs que les comprimés)
 - **Prise de drogue**
 - **Consommation d'alcool**
 - **Sportifs de haut niveau** : les boissons énergétiques, les nageurs avec le chlore
 - **Environnement professionnel** : les patients qui travaillent dans l'industrie chimique, avec un environnement acide dans l'air qu'ils respirent en permanence ou l'industrie viticole
- Intrinsèques
 - **Reflux gastriques** (RGO)
 - **Troubles du comportements alimentaires** (TCA)
 - **Vomissements chroniques**

C'est important de connaître tous ces facteurs extrinsèques et intrinsèques pour orienter le questionnaire face à un patient chez qui on va potentiellement diagnostiquer des lésions érosives. C'est important de savoir tout ce qui pourrait causer ces pertes de substances.

Parfois, ça touche des choses dont les patients ne veulent pas parler aux premières consultations (alcoolisme chronique, trouble du comportement alimentaire, etc).

Ce sont des choses qu'il va falloir réaborder lors des consultations suivantes avec de la confiance. Il faut parfois une prise en charge pluridisciplinaire qui est nécessaire que ce soit par un psychologue, un addictologue, ou un nutritionniste aussi très souvent.

Question n°7 : Les boissons énergétiques ont un fort potentiel érosif sur l'émail dentaire.

VRAI.

C'est vraiment important de faire de la prévention lorsque l'on a des patients sportifs pour limiter la perte de substances chez ces populations.

Il est intéressant de conseiller des rinçages avec bain de bouche pour permettre de favoriser la reminéralisation.

Question n°8 : Les LCNC affectent principalement la face vestibulaire des dents.

VRAI.

Les LCNC sont souvent en vestibulaire, que ce soit lié aux contraintes ou au brossage traumatique.

Il est en effet plus rare d'avoir des lésions cervicales côté lingual ou palatin, voire ça n'arrive jamais. Ces lésions sont généralement dues à des causes multiples : d'une part, une composante érosive qui fragilise et ramollit l'émail superficiel, et d'autre part, une composante mécanique, souvent liée à un brossage abrasif. C'est typiquement le cas des patients qui brossent leurs dents de manière très horizontale, ce qui endommage la zone cervicale au niveau de la jonction amélo-cémentaire. Par conséquent, ces lésions cervicales se trouvent principalement sur la face vestibulaire des dents.

Question n°9 : L'abrasion peut être causée par un brossage horizontal trop appuyé.

VRAI.

C'est important de bien faire de **l'éducation thérapeutique** auprès des patients lors de la première consultation et de vraiment étudier tous les paramètres qui pourraient influencer ces pertes de substance.

On a l'impression que le brossage dentaire est simple et maîtrisé par tout le monde, mais en réalité ce n'est jamais vraiment bien fait. On peut aussi conseiller au patient de s'orienter vers le brossage électrique. Avec le brossage manuel, il faut faire attention au mouvement de brossage mais aussi à la force appliquée et au type de brosse à dent achetée. Tous ces éléments peuvent entraîner des pertes de substances.

Question n°10 : Les personnes végétariennes ont moins de risques d'abrasion dentaire que les personnes omnivores.

FAUX.

Les personnes végétariennes ont plus de risques d'abrasion. En effet, le régime végétarien est associé à une augmentation de l'acidité de l'alimentation. Cela est dû à la consommation de fruits acides, à la consommation de jus de fruits, tout ce qui est vinaigre, vinaigrette, etc. Ces choses sont très nocives (acidité) pour les dents. Il est important de les sensibiliser, surtout avec la hausse du nombre de personnes végétariennes, afin de leur fournir des conseils de prévention adaptés.

Question n°11 : Le ciment est constitué de 70% de matière minérale.

FAUX.

La dentine c'est autour de 70%, le ciment c'est **60%**.

Ce qui est important à retenir, ce n'est pas le pourcentage, mais savoir que c'est un tissu qui est moins minéralisé et qui va être beaucoup plus susceptible aux pertes de substance.

Question n°12 : La diminution de la salive favorise les lésions érosives.

VRAI.

On a déjà cité les antidépresseurs et les médicaments. L'âge a également un impact sur la diminution du flux salivaire.

Ensuite, il y a certaines pathologies qui peuvent influencer, comme le syndrome de Gougerot-Sjögren (**à retenir**). C'est une maladie auto-immune qui est souvent associée à des manifestations oculaires et parfois gynécologiques. Les patients atteints nécessitent généralement une prise en charge pluridisciplinaire pour répondre à la diversité de leurs symptômes.

Question n°13 : Les lésions d'abfraction sont souvent en forme de V.

VRAI.

Pour rappel :

- **Lésions abrasives** : en **forme en U**, avec des bords plus arrondis.
- **Lésions abfractions** : en forme de V

Bien que leur origine soit encore sujette à débat et controversé, ces lésions présentent une morphologie typique en forme de "**coup de hache**". Elles se caractérisent par une lésion **en V**, très **anguleuse**, souvent **fine** en forme de **demi-lune** et assez **profonde**. Cette forme est souvent associée à l'abfraction, bien que d'autres facteurs pourraient aussi expliquer cette morphologie.

- **Lésions érosives** : Atténuation progressive des reliefs de morphologie dentaire : elles sont souvent plus larges que profondes.

Les signes cliniques observés en bouche sont essentiels car vont permettre de nous orienter vers les facteurs de risque.

Question n°14 : Les lésions érosives au stade avancé peuvent exposer la dentine.

VRAI. (cf article écrit par la prof et Léa Masset)

L'exposition de la dentine à un stade avancé de lésions érosives est possible par un amincissement de l'émail.

En effet, il existe différents stades de lésions **érosives**:

- Dans les premiers stades, seules les couches superficielles de l'émail sont affectées.
- À un stade plus avancé, on peut commencer à voir la dentine par transparence. Cela peut être observé même chez les jeunes patients, notamment sur les faces occlusales, qui deviennent légèrement jaunâtres. Cela se produit parce que l'émail

s'amincit, laissant apparaître la dentine en dessous. À ce stade, les patients commencent souvent à ressentir de la **sensibilité**, notamment au **chaud**, au **froid** ou au **sucré**, car la protection apportée par l'émail est insuffisante, exposant davantage la dentine.

Lorsque la dentine est exposée, on peut parfois observer des **hyperesthésies** (=exacerbation des sens), mais ce n'est pas systématique. Cette dentine réagit à l'agression externe en se minéralisant pour limiter la sensibilité on parle **d'hyperminéralisation dentinaire** qui est un mécanisme de défense à l'agression. Les tubules dentinaires s'hyperminéralisent, afin de réduire la circulation de l'eau, de l'air, du chaud et du froid, ce qui protège la pulpe et les nerfs. Une **dentine réactionnelle** peut se former, qui est très sclérotique et minéralisée.

- Dans les stades les plus avancés de l'érosion, on peut même apercevoir la pulpe par transparence. À ce stade, la dentine sclérotique est très fine et permet de voir la morphologie du canal radiculaire ou de la chambre pulpaire. Ces stades sont plus graves, mais ils sont fréquemment observés chez des patients, souvent plus âgés.

Question n°15 : Le vieillissement physiologique ne provoque pas d'usure dentaire.

FAUX.

Il faut bien distinguer usure pathologique et usure physiologique parce que la prise en charge ne sera pas du tout la même.

On peut avoir chez certains patients plus âgés une usure qui va être relativement avancée mais qui finalement va être normale compte tenu de l'âge du patient et ce ne sera absolument pas quelque chose de problématique. En effet, l'usure physiologique (à la différence de l'usure pathologique) ne va pas forcément nécessiter un traitement ou une réhabilitation car il n'y a pas de problèmes fonctionnels.

Il y a plein de phénomènes de compensation qui surviennent de manière à compenser ces pertes de substance comme l'égression compensatoire.

Au fil du temps, lorsqu'on est face à une usure physiologique, on va avoir une diminution de la hauteur de la couronne dentaire par perte de substance. En termes de réaction, l'organisme est relativement bien fait, les dents vont avoir un phénomène d'égression compensatoire : elles vont avoir tendance à sortir légèrement de leur plan d'occlusion de manière à compenser, à retrouver un contact normal avec l'arcade antagoniste.

Souvent, cette égression compensatoire s'accompagne aussi du niveau osseux, donc on a un bon maintien du niveau osseux. Effectivement, ce n'est pas simplement la dent qui s'égrène, mais elle s'accompagne d'une égression du tissu osseux, ce qui rend cette égression compensatoire non problématique. Elle peut même être bénéfique en résolvant

certaines problématiques occlusales qui pourraient survenir en cas d'usure dentaire trop rapide et pathologique.

Question n°16 : Les abrasions en U sont souvent causées par le brossage horizontal.

VRAI.

L'**abrasion** est un mécanisme d'usure à deux ou trois corps, généralement caractérisé par la présence d'une particule abrasive associée à un mouvement au niveau de l'interface (brossage traumatique).

Tout ce qui est parafunctionnel ou les mauvaises habitudes peuvent également causer de l'abrasion. Par exemple, les patients qui mettent leur instrument de travail en bouche, ou les patients qui se rongent les ongles, peuvent avoir des lésions abrasives au niveau de leurs dents.

Question n°17 : Le reflux gastro-oesophagien est un facteur intrinsèque de l'érosion dentaire.

VRAI.

Etre capable de : savoir lister les facteurs **intrinsèques** et les facteurs **extrinsèques** et de les avoir bien en tête.

Des lésions érosives présentent d'un côté plus que de l'autre est caractéristique des patients qui ont des RGO (lorsque le patient dort d'un côté les reflux acides vont stagner et endommager un côté plus que l'autre).

Important à savoir : une grande majorité des patients qui présentent des reflux gastro-oesophagien ne s'en rend absolument pas compte, c'est complètement asymptomatique. Donc le fait de poser des questions sur les brûlures d'estomac ou les remontées acides peut nous guider sur certains patients qui sont symptomatiques et qui ont déjà un traitement pour l'acidité gastrique, mais il y a une grosse part de patients qui n'est absolument pas diagnostiquée et chez qui au quotidien ça n'entraîne pas de répercussions particulières.

C'est pour ça que c'est important d'avoir un interrogatoire ultra complet de manière à fonctionner en terme d'exclusion des facteurs de risques. Si toutefois on a exclu l'ensemble des facteurs de risques auxquels on pense et qu'il ne nous reste plus que celui-ci, ça peut être intéressant d'orienter le patient vers un gastro-entérologue pour faire un diagnostic et voir si oui ou non il y a une pathologie à prendre en charge de ce côté-là.

Au niveau alimentaire également, le premier interrogatoire va être un peu faussé car beaucoup de patients ne se rendent pas forcément compte de leurs habitudes alimentaires réelles. Ils vont avoir l'impression d'avoir une consommation alimentaire relativement normale. Si on leur demande pour la séance suivante de tenir un petit **journal diététique**

sur 4/5 jours, de noter les prises alimentaires, de boissons, etc, ça permet parfois de mettre en évidence des habitudes inadaptées et de pouvoir les orienter chez un nutritionniste si jamais le patient n'arrive pas à gérer seul ses habitudes. Ce sont des choses qui lors d'une première discussion n'apparaissent pas forcément.

Question n°18 : Les processus d'abfraction touchent principalement les faces occlusales.

FAUX.

L'**abfraction** est en lien avec des contraintes occlusales excessives mais les lésions sont au niveau cervical. (ça ne correspond pas aux pertes de substance qu'on a au niveau occlusal)

C'est l'**attrition** qui explique ces pertes de substances liées au contact dento-dentaire au niveau occlusal. L'**abfraction** entraîne les lésions au niveau cervical, au niveau de la jonction amélo-cémentaire, par fragmentation des tissus minéralisés.

Question n°19 : La prise en charge des LCNC inclut l'utilisation de fluorations pour renforcer l'émail.

VRAI.

La fluoration est utilisée et voici les thérapeutiques (ici les molécules) que l'on peut proposer au patient hormis du fluor :

- **La phosphopeptide de caséine-phosphate de calcium amorphe (CPP-ACP)** qui est très connue et qui aide à la minéralisation : relargage de phosphate et calcium
- **L'arginine**
- **Hydroxyapatite**
- Des produits à base de fluorure comme le **fluorure de potassium**, le **fluorure de strontium**, **chlorure de strontium**, etc

C'est important de connaître globalement l'arsenal thérapeutique et quel type de molécule on peut être amenés à prescrire à nos patients, sans connaître uniquement le nom du produit commercial.

Question n°20 : Les restaurations en composite ne sont pas affectées par les attaques acides.

VRAI. (cf article écrit par Dr Olivia Kerouredan et Dr Léa Masset)

Ce qui est typique de l'**érosion dentaire** c'est justement que les restaurations, qu'elles soient composites ou amalgames, ne vont pas être affectées par les attaques acides. On va avoir des restaurations qui vont se retrouver en sur-contour parce que les tissus dentaires environnants vont avoir diminué à cause de ces phénomènes érosifs. C'est un premier signe

d'alerte qui est assez intéressant à identifier parce que ça met clairement en évidence qu'il y a eu une perte de substance et qu'il y a donc des facteurs de risques à prendre en charge chez le patient.

Ça ne correspond pas du tout à ce que l'on pourrait retrouver dans le cas d'usure attritionnelle parce qu'au contraire, dans le cas de **l'attrition**, c'est du contact dento-dentaire donc on aura également l'usure des matériaux d'obturation en même temps.

Question n°21 : La consommation régulière d'alcool est un facteur de risque d'érosion.

VRAI.

La consommation régulière d'alcool (tout comme la consommation régulière de sodas) va aussi entraîner d'autres problématiques, notamment davantage de reflux gastro-oesophagiens (RGO) et de vomissements chroniques. C'est un cercle vicieux qui accentue encore plus les pertes de substance.

Question n°22 : Les lésions érosives au niveau des cuspides sont souvent en forme de cupule.

VRAI.

Les cupules sont des signes d'érosion : c'est un signe d'alerte qui est très caractéristique et dont il faut bien se rappeler !! Il y a encore énormément de praticiens travaillant en cabinet qui associent ces lésions en cupule à des lésions attritionnelles : ce qui n'est pas du tout le cas!

Avant, on ne trouvait pas souvent de lésions érosives en cabinet et c'était du à :

- au fait que l'érosion n'était pas vraiment enseignée (et donc souvent prise pour de l'attrition)
- au fait qu'elles sont difficiles à évaluer dès les premiers stades de développement

Mais désormais que c'est mieux enseigné : le diagnostic est mieux réalisé et le nombre observé au fauteuil est plus important.

En aucun cas les lésions cupulaires correspondent à des lésions attritionnelles. Les lésions attritionnelles correspondent à des facettes d'usure, tandis que les lésions en cupule au niveau des pointes cuspidiennes sont caractéristiques de l'érosion. Dès qu'on voit ces lésions sur un patient, ça nous permet d'établir un diagnostic ultra précoce et éviter que les pertes de substance s'accroissent dans le temps. On peut le détecter dès l'âge de 15/16 ans, parfois ce sont des lésions qui sont visibles sur les molaires. Donc il ne faut pas hésiter à en parler directement au patient, à mettre en œuvre des démarches préventives et aussi le monitoring lésionnel de manière rapprochée le temps que le patient puisse changer ses habitudes alimentaires ou autre.

S'il y a bien un signe clinique à retenir dans le diagnostic de l'érosion, c'est la présence de ces lésions en cupule.

Les lésions en cupule sont donc au niveau des **faces occlusales**.

Quels sont les types de lésions caractéristiques chez les patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire (TCA) ?

On rappelle que les TCA sont un facteur intrinsèque, essentiellement avec les vomissements. Lors des vomissements, les faces dentaires les plus affectées sont les **faces palatines**, et notamment les incisives maxillaires. On observe une disparition du cingulum et des faces palatines qui sont toutes lisses et planes au lieu d'avoir les reliefs anatomiques. C'est très caractéristique.

Souvent lors des reflux gastro-oesophagiens, on a beaucoup d'atteinte localisée au niveau des **secteurs postérieurs mandibulaires**, tout simplement parce que la salive va stagner à cet endroit.

L'observation visuelle est encore une fois, tout comme pour les caries, importante pour la détection des lésions érosives. C'est l'observation qui va permettre le diagnostic et qui va nous guider vers les facteurs de risque. Sans même que le patient ait répondu à l'interrogatoire, rien qu'en observant l'aspect lésionnel au niveau des dents, on doit déjà être guidés vers certaines pistes en termes de facteurs de risques intrinsèques, extrinsèques, plutôt alimentaires ou pas.

Parfois, quand ce sont des lésions plus localisées au niveau des faces vestibulaires, on va davantage s'orienter vers des facteurs d'origine extrinsèque, et donc des comportements alimentaires nocifs.

Il faut faire attention aussi à ce qu'on peut trouver sur internet. Beaucoup de patients prennent du jus de citron avec du bicarbonate et le mettent sur leur brosse à dent, et vont frotter histoire de bien « décaper », dans le but de blanchir leurs dents. Mais c'est un cercle vicieux car les patients trouvent qu'ils ont les dents trop jaunes et vont abraser et éroder leurs dents. Du coup, l'épaisseur de l'émail va s'affiner, donc on verra davantage par transparence la dentine qui, elle, est saturée et donc ils vont rentrer dans ce cercle vicieux et continuer à provoquer des lésions.

Question n°23 : Les lésions érosives asymptomatiques sont difficiles à détecter sans examen clinique.

VRAI.

Pendant longtemps, l'aspect préventif était délaissé. Désormais le travail de chirurgien-dentiste c'est avant tout, non pas de restaurer, mais de **prévenir les pertes de substances**. On veut éviter d'avoir à « réparer » les dents par la suite.

Les lésions érosives sont asymptomatiques jusqu'à très tard. Parfois, on va avoir même des lésions érosives qui sont relativement sévères, mais qui vont rester asymptomatiques car, vu que c'est un processus lent, l'organe dentaire va avoir tous ses processus de défense qui vont se mettre en place pour essayer d'éviter d'atteindre la pulpe dentaire.

Les patients ne viennent donc consulter que très tardivement car en général quand ils n'ont pas de douleurs ils se passent très bien d'aller chez le dentiste. C'est ce qui rend compliqué à gérer ces lésions : les patients ne viennent consulter que lorsqu'ils ont mal et donc que les lésions se sont vraiment beaucoup développées : ils viennent très/trop tard !

C'est pour ça que c'est au chirurgien-dentiste, lors des visites de contrôle, de faire de la prévention et de faire un examen clinique approfondi pour dépister très précocement. Dès qu'il y a un doute, on fait systématiquement des photographies pour figer l'état bucco-dentaire initial du patient. C'est un bon outil pour discuter avec le patient, et avoir un suivi sur le long terme.

Question n°24 : Les usures interproximales dépendent de l'âge et du cycle de mastication.

VRAI.

Les usures interproximales sont plutôt en lien avec les phénomènes attritionnels, donc tout ce qui est contrainte de **mastication**. Effectivement, le point de contact n'est pas figé et fixe dans le temps. On va avoir une usure progressive où les points de contact vont se transformer en surface de contact et cela entraîne davantage de problématiques en terme de lésions carieuses et d'atteinte parodontale.

C'est de l'usure qui est parfois pathologique mais aussi physiologique, c'est normal qu'il y ait cette évolution dans le temps. (le vieillissement physiologique est accompagné de phénomènes d'attrition)

Question n°25 : Les érosions d'origine extrinsèque se produisent principalement sur les surfaces linguales des dents.

FAUX.

C'est essentiellement sur les **faces vestibulaires** et aussi au niveau des **faces occlusales**.

Il y a une correspondance entre les facteurs provoquant la lésion et la localisation de la lésion : sa localisation nous aidera donc à avoir des pistes pour les facteurs.